PLAYBOOK

COMMERCIAL DOTR

FORMATION COMMERCIALE · MODULE INITIAL
REF : 008.2 - MODULE 1

COMPRENDRE NOS ÉTABLISSEMENTS CIBLES—De l'EHPAD à l'ensemble du médico-social



20
26.

Formation commerciale
Docs On The Road

Site web
www.docsontheroad.fr

NOTRE TERRAIN DE JEU



Docs On TheRoad
DOTR

Notre mission : apporter du temps médical et paramédical aux établissements médico-sociaux en difficulté d'accès aux soins, là où les ressources manquent.

Notre organisation repose sur trois modes complémentaires : Télémédecine · Télécoordination · Présentiel programmé.

Médecine Générale

Suivi médical régulier, gestion des urgences différées, prescriptions et bilans. DOTR assure une présence médicale structurée etdurable dans l'établissement.

Médecine de Coordination

Organisation du parcours de soins, lien ville-établissement, pilotage des protocoles et coordination pluriprofessionnelle pour les résidents complexes.

MPR · Psychiatrie · Pédopsychiatrie

Médecine Physique et de Réadaptationpour lespublics handicap moteur ; Psychiatrie et Pédopsychiatrie pour les troubles psychiques et comportementaux en établissement.

Orthophonie

Bilans,rééducation et suivi orthophonique en téléconsultation ou présentiel programmé. Priorité aux IME, CAMSP, CMPP et établissements handicap enfant.

CE QUE DOTR APPORTE AUX ÉTABLISSEMENTS

Une organisation médicale pensée autour de l'établissement, et non l'inverse. Six leviers concrets pour renforcer l'accès aux soins et sécuriser le parcours des personnes accompagnées.



Temps Médical



Médecin Référent



Téléconsultation



Coordination des Parcours



Réunions Pluri-pro



Présentiel Programmé

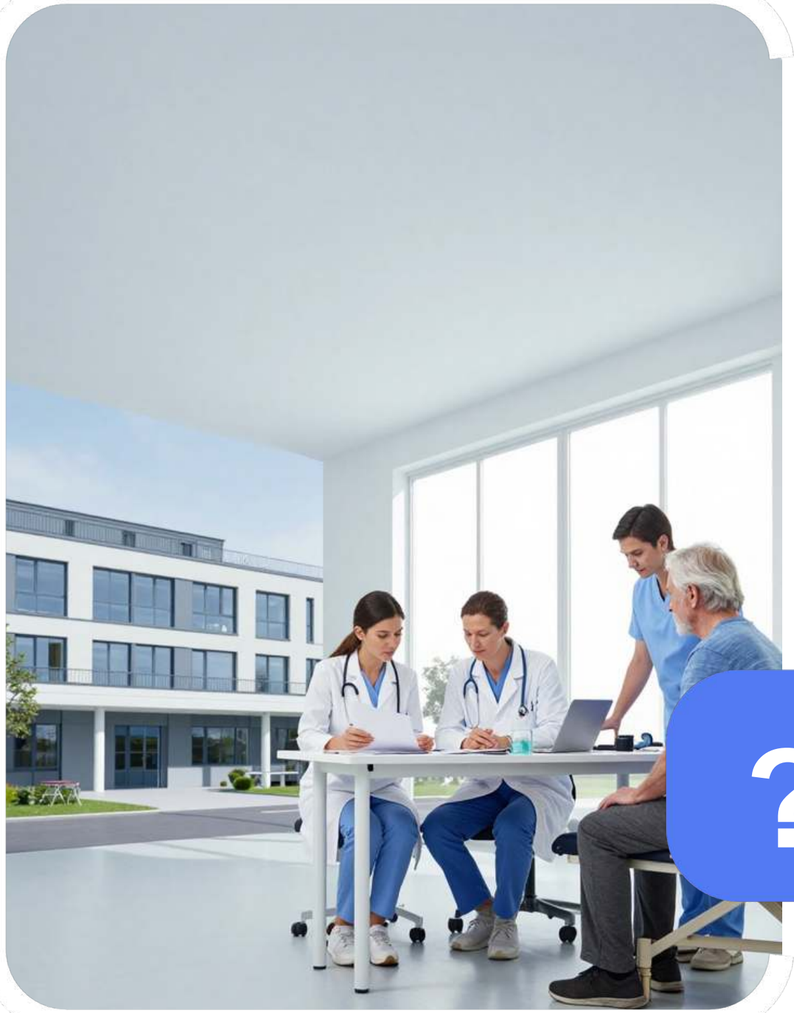
Liceria & Co.
Company

LA CARTE DU MARCHÉ DOTR

P1 — SENIORS : EHPAD,MAS,FAM/EAM,EEAP
P1 — HANDICAP : MAS,FAM/EAM, EANM,SAMSAH,IME,IEM, ITEP/DITEP
P2 — HANDICAP :SESSAD, CAMSP, CMPP
P2 — ENFANCE & AMBULATOIRE : CMPP, CAMSP, SESSAD
P3 — EXTENSIONS : ESAT, Résidence Autonomie, Résidence Services Seniors, SSIAD/SAD

5 univers d'établissements cibles — du plus médicalisé au moins médicalisé.

Chaque univers correspond à un niveau de priorité commerciale (P1, P2, P3) et à des expertises DOTR spécifiques : Médecine Générale, Coordination, MPR, Psychiatrie/Pédopsychiatrie, Orthophonie.



?

Comment Lire

Une Structure Médico-Sociale

Qui est accompagné ?

Où vit la personne ?

Niveau de médicalisation ?

Ressource médicale manquante ?

Professionnels présents sur site ?

Identifier les équipes soignantes en place, les postes vacants et lesmissions externalisées pour repérer les manques réels.

Organisation possible à distance ?

Évaluer la compatibilité avec la télémédecine, la télécoordination et le présentiel programmé DOTR.

ÉCHELLE DE MÉDICALISATION

De la résidence autonome à la MAS ou l'EEAP, chaque structure a un niveau de médicalisation différent. Ce niveau détermine directement l'intensité des besoins médicaux et les opportunités DOTR.

⚠ Le niveau réel dépend toujours du profil de la structure et des personnes accompagnées. Ces repères sont des indicateurs, non des règles absolues.

Docs On The Road
DOTR

FAIBLE → MODÉRÉ

Résidence services seniors · Résidence autonomie · ESAT · EANM / Foyer de vie
Peu ou pas d'infirmiers permanents. Médecin libéral de ville. Soins ponctuels.

MODÉRÉ → IMPORTANT

SESSAD · CAMSP · CMPP · SAMSAH · IME · ITEP/DITEP · IEM
Infirmiers présents, médecin coordonnateur ou psychiatre. Soins réguliers et coordination renforcée.

TRÈS IMPORTANT

EHPAD · FAM / EAM · MAS · EEAP
Infirmiers 24h/24, médecin coordonnateur obligatoire. Soins complexes, polyhandicap, dépendance lourde.

EHPAD

Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

C'EST QUOI / PUBLIC



Structure médicalisée hébergeant des personnes âgées en perte d'autonomie.

PUBLIC : personnes âgées 60+ avec dépendance (GIR 1 à 4).

FONCTIONNEMENT : hébergement permanent, USLD, unités Alzheimer.

MÉDICALISATION : très importante — médecin coordonnateur, IDE, aides-soignants. INTERLOCUTEURS : Directeur, médecin coordonnateur, IDEC, cadre de santé.

OPPORTUNITÉS / PITCH



BESOINS : médecin généraliste, coordination parcours, téléconsultation spécialisée, réunions pluripro.

OPPORTUNITÉS DOTR★★★★★ : MG, Coordination, Psychiatrie, Orthophonie.

SIGNAUX : poste médecin coordonnateur vacant, délais spécialistes, hospitalisations évitables.

PITCH : « Nous organisons une ressource médicale durable autour de votre établissement. »

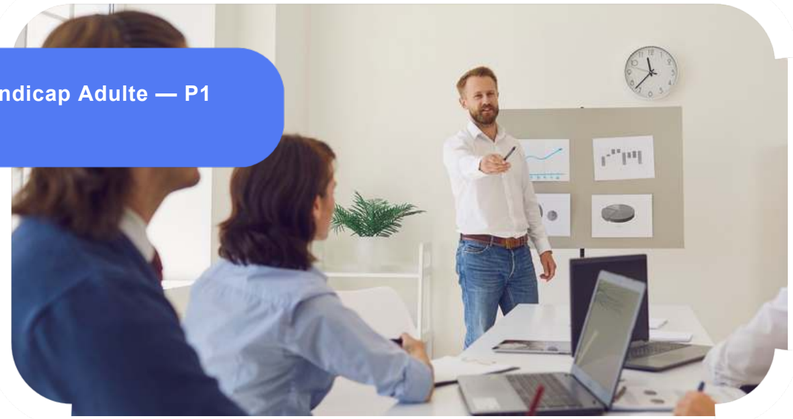
EN 10 SECONDES : L'EHPAD est notre cible P1 — fort besoin médical, interlocuteurs identifiés, compatibilité totale DOTR.

MAS

Maison d'Accueil Spécialisée

Liceria & Co.
Company

Handicap Adulte — P1

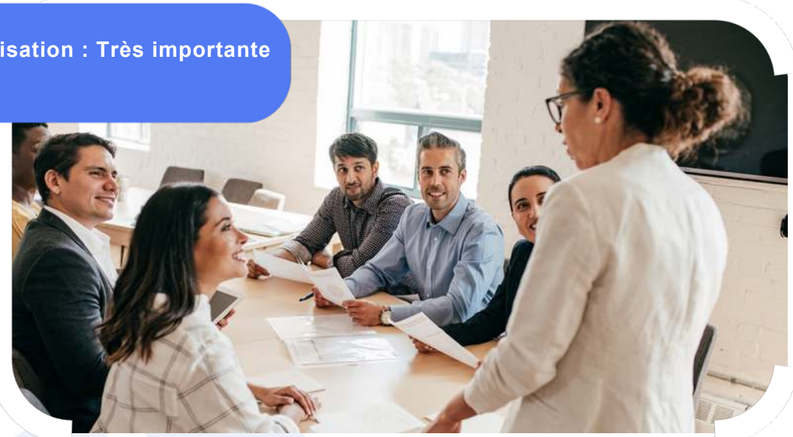


C'ESTQUOI ?
Structure médico-sociale accueillant des adultes en situation de handicap sévère ou de polyhandicap nécessitant une prise en charge médicale et paramédicale continue. Hébergement permanent avec soins 24h/24.

PUBLIC : Adultes polyhandicapés, handicap moteur sévère, handicap cognitif profond, dépendance totale pour les actes de la vie quotidienne.

FONCTIONNEMENT : Équipe pluriprofessionnelle (IDE, AS, AMP/AES, kinés, ergos, orthophonistes). Médecin coordonnateur souvent absent ou à temps très partiel. Financement ARS via dotation globale.

Médicalisation : Très importante



INTERLOCUTEURS : Directeur d'établissement, médecin coordonnateur (si présent), cadre de santé, chef de service éducatif.
BESOINS MÉDICAUX :
Médecine générale de proximité ★★★ — MPR (rééducation, spasticité, appareillage) ★★★ — Psychiatrie adulte ★★★ — Orthophonie ★★ — Coordination parcours ★★★
OPPORTUNITÉS DOTR : Médecin référent téléconsultation ★★★ — Médecin coordonnateur externalisé ★★★ — MPR en télécoordination ★★★ — Psychiatrie ★★★ — Réunions pluripro ★★★
SIGNAUX :
Kinés et ergos présents mais sans médecin MPR référent — Hospitalisations évitables fréquentes — Médecin coordonnateur absent ou surchargé — Difficultés de gestion des troubles du comportement.
QUESTIONS CLÉS :
« Qui prescrit et coordonne les soins de rééducation actuellement ? »
« Comment gérez-vous les situations de crise comportementale ? » — « Votre médecin coordonnateur est-il présent à temps suffisant ? »
PITCH DOTR :
« Nous organisons une ressource médicale durable autour de votre MAS : médecin référent, MPR, psychiatrie et coordination, en téléconsultation et en présentiel programmé, selon les besoins réels de vos résidents. »
EN 10 SECONDES — MAS : Adultes polyhandicapés, médicalisation très importante, manque critique de MPR et de médecin coordonnateur. DOTR apporte médecin référent, MPR et psychiatrie. Priorité P1.

Foyer d'Accueil Médicalisé / Établissement d'Accueil Médicalisé

PUBLIC & FONCTIONNEMENT



Adultes en situation de handicap sévère nécessitant hébergement permanent et soins réguliers. Polyhandicap, handicap moteur ou psychique lourd.
Médicalisation importante : infirmiers, aides-soignants, rééducateurs.
Interlocuteurs : Directeur, médecin coordinateur, cadre de santé, chef de service éducatif.

OPPORTUNITÉS DOTR



Opportunités prioritaires P1 : MPR (rééducation, spasticité, douleur), Médecine Générale (suivi chronique), Psychiatrie (troubles du comportement), Orthophonie (communication, déglutition).
Signal fort : kinés/ergos sans appui MPR.
Pitch : « Nous organisons le temps médical spécialisé dont vos résidents ont besoin, en téléconsultation et en présentiel programmé. »

IME

Institut Médico-Éducatif

PUBLIC



Enfants et adolescents (6–20 ans) présentant une déficience intellectuelle, des troubles du neurodéveloppement (TND), des troubles du spectre autistique (TSA) ou des handicaps associés.

L'IME assure à la fois soin, éducation et accompagnement vers l'autonomie, en internat ou semi-internat.

PRIORITÉ



Spécialités phares : Pédopsychiatrie (P1) · Orthophonie (P1) · Médecine Générale (P2).
Interlocuteurs clés : Directeur d'établissement, Médecin psychiatre coordonnateur, Chef de service éducatif, Infirmière coordinatrice.
Signaux d'opportunité : file psy saturée, délais orthophonie, absence de médecin référent, besoins de coordination pluriprofessionnelle non couverts.

IEM

Institut d'Éducation Motrice

PUBLIC



Enfants et adolescents présentant un handicap moteur important, souvent associé à des troubles cognitifs ou sensoriels.
Hébergement ou accueil de jour.
Accompagnement pluridisciplinaire intensif axé sur la rééducation motrice, l'autonomie et la scolarisation adaptée.

OPPORTUNITÉS DOTR



Spécialité phare : MPR (Médecine Physique et de Réadaptation).
Forte compatibilité téléconsultation MPR et coordination pluriprofessionnelle.
Signaux clés : kinésithérapeutes et ergothérapeutes sans médecin MPR référent.

Question clé : « Avez-vous un médecin MPR qui coordonne les rééducations ? »

EEAP

Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés

PUBLIC



Enfants et adolescents présentant un polyhandicap sévère : déficiences motrices et intellectuelles profondes associées, troubles sensoriels, épilepsie.
Dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne.
Accompagnement global 24h/24 en établissement spécialisé.

MÉDICALISATION



Niveau : TRÈS IMPORTANT ●●●●●
Médecin coordonnateur, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes. Besoins MPR, pédopsychiatrie, orthophonie et coordination pluriprofessionnelle.

Opportunités DOTR : ★★★★★ — Compatibilité maximale téléconsultation + présentiel programmé.

ITEP / DITEP

Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique

C'EST QUOI ?



Établissement médico-social accueillant des enfants et adolescents présentant des troubles psychologiques, du comportement ou de la personnalité perturbant gravement leur socialisation et leur accès aux apprentissages.

L'ITEP associe soins, éducation et pédagogie.

Le DITEP est le dispositif intégré permettant des passages souples entre les modalités d'accueil (internat, semi-internat, ambulatoire).

FONCTIONNEMENT & PUBLIC



PUBLIC : Enfants et adolescents (6-20 ans) avec troubles psychologiques ou comportementaux sévères, sans déficience intellectuelle primaire.

INTERLOCUTEURS : Directeur, médecin psychiatre coordinateur, chef de service éducatif, psychologue.
SPÉCIALITÉ PHARE : Pédopsychiatrie ★★★ | Orthophonie ★★ | Médecine Générale ★.

EN 10 SECONDES : L'ITEP/DITEP a besoin d'un appui psychiatrique structuré et d'une coordination médicale pour soutenir des équipes face à des troubles complexes.

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

C'EST QUOI ?



Service ambulatoire intervenant directement au domicile ou en milieu scolaire/professionnel. Le SESSAD accompagne des enfants et adolescents en situation de handicap (moteur, mental, sensoriel, troubles du comportement) sans hébergement.
L'équipe pluridisciplinaire se déplace auprès des jeunes.
Priorité : P2. Code : Handicap Enfant.

TÉLÉCOORDINATION



Opportunité clé DOTR : la télécoordination est le levier central. Les équipes terrain (éducateurs, rééducateurs, paramédicaux) ont besoin d'un médecin coordonnateur accessible à distance. Orthophonie, pédopsychiatrie et MPR en téléconsultation complètent l'offre.

Signal fort : absence de médecin référent structurant les parcours et les réunions pluriprofessionnelles.

CAMSP

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

C'EST QUOI ?



Structure ambulatoire médico-sociale dédiée au dépistage précoce, au diagnostic et à la prise en charge des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles du développement, des déficits sensoriels ou moteurs, ou des risques de handicap.
Fonctionnement en équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, orthophoniste, kinésithérapeute, éducateur).
Financement ARS sur enveloppe médico-sociale.
Interlocuteurs : directeur, médecin responsable, chef de service.

OPPORTUNITÉS DOTR



★★★ Orthophonie : bilans et suivis de troubles du langage et de la communication dès le plus jeune âge.
★★★ Pédopsychiatrie : évaluation des troubles du neuro-développement (TSA, TDAH, retard global).
★★ Médecine de coordination : appui au médecin responsable, synthèses pluridisciplinaires, téléconsultations.

SIGNAUX : liste d'attente orthophonie > 3 mois · départ d'un médecin coordinateur · demandes de bilan TSA en hausse · partenariat avec PMI ou maternité.

QUESTIONS CLÉS : « Quel est votre délai moyen pour un bilan orthophonique ? » · « Avez-vous un pédopsychiatre référent disponible ? » · « Comment gérez-vous les synthèses pluridisciplinaires ? »

PITCH : DOTR organise une ressource en orthophonie et pédopsychiatrie accessible en téléconsultation, réduisant vos délais de bilan et renforçant votre équipe sans recrutement.

EN 10 SECONDES — CAMSP : petite enfance 0–6 ans, dépistage et prévention du handicap, opportunité forte orthophonie + pédopsychiatrie, approche télécoordination.

CMPP

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

C'EST QUOI ?



Structure ambulatoire médico-sociale accueillant des enfants et adolescents (0-20 ans) présentant des troubles psychologiques, du comportement, des apprentissages ou du développement. Fonctionnement en consultations externes, sans hébergement.

Financé par l'Assurance Maladie (OQN).

PUBLIC & FONCTIONNEMENT



Enfants et adolescents jusqu'à 20 ans. Troubles dys, TDAH, troubles anxieux, troubles du comportement, retards de développement.
Équipe pluridisciplinaire : pédopsychiatre, psychologue, orthophoniste, psychomotricien.
File active importante, délais de prise en charge longs.

Médicalisation : modérée — pédopsychiatre directeur médical.

Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

C'EST QUOI ?



Service médico-social non hébergement accompagnant à domicile des adultes en situation de handicap avec des besoins médicaux et sociaux importants.
Assure soins, coordination et soutien à l'autonomie via une équipe pluriprofessionnelle (infirmiers, AS, psychologue, médecin).

Financement ARS, agrément CPOM.

PUBLIC & FONCTIONNEMENT



Adultes handicapés (moteur, psychique, cognitif) vivant à domicile avec dépendance partielle. Équipe mobile pluriprofessionnelle.
File active de 30 à 60 personnes.
Médecin souvent extérieur ou absent.
Coordination avec médecin traitant, spécialistes, hôpital.
Télécoordination fortement adaptée au modèle.

Établissement d'Accueil Non Médicalisé / Foyer de Vie

C'EST QUOI ?



Structure médico-sociale hébergeant des adultes handicapés dont l'état ne nécessite pas de soins médicaux constants. Le foyer de vie assure un accompagnement éducatif, social et une aide à la vie quotidienne.
Moins médicalisé que le FAM ou la MAS, mais des besoins médicaux réels existent malgré tout au quotidien.

OPPORTUNITÉS DOTR



PUBLIC : Adultes en situation de handicap (mental, psychique, moteur) avec autonomie partielle.
INTERLOCUTEURS : Directeur, chef de service éducatif, infirmier coordinateur. **BESOINS** : Médecine générale ponctuelle, suivi psychiatrique, orthophonie, coordination des parcours de soins.
OPPORTUNITÉS★★★ : Téléconsultation MG, psychiatrie à distance, orthophonie, télécoordination.
SIGNAL : Turnover médecin traitant, hospitalisations évitables, équipe sans appui médical structuré.
PITCH : « Même sans médicalisation lourde, vos résidents ont des besoins médicaux réels. DOTR organise une ressource médicale souple, à distance et en présentiel, adaptée à votre structure. »

Établissement et Service d'Accompagnement par le Travail

Priorité P3



C'EST QUOI ? Structure médico-sociale accueillant des adultes en situation de handicap pour exercer une activité professionnelle adaptée.
L'ESAT n'est pas un lieu de soins : c'est un environnement de travail protégé. Médicalisation faible à très faible.

Public cible



PUBLIC : Adultes handicapés (psychique, mental, moteur léger) avec capacité de travail réduite. Pas de dépendance lourde. BESOINS : Médecine générale ponctuelle, suivi psy si troubles associés, orthophonie rare.

PITCH DOTR : « Si vos travailleurs ont des besoins médicaux non couverts, nous pouvons organiser un accès médical souple, sans surcharger votre équipe. »

EN 10 SECONDES — ESAT P3 : Ne prospecter qu'en présence d'un besoin médical identifié. Priorité basse. Signal fort = troubles psy ou suivi médical insuffisant.

RÉSIDENCE AUTONOMIE

P3 — Seniors



C'ESTQUOI ? Résidence collective pour personnes âgées autonomes ou peu dépendantes (GIR 5-6).
Logements privatifs avec services collectifs optionnels.
Anciennement « logement-foyer ». Pas de soins intégrés.

Financement : aide sociale au logement, pas de dotation soins.

Non médicalisé



OPPORTUNITÉS DOTR : Téléconsultation de médecine générale pour résidents sans médecin traitant. Prévention, bilans de santé, coordination avec médecins de ville. Orthophonie et psychiatrie en cas de début de fragilité.

PITCH : “Nous permettons à vos résidents d'accéder à un médecin sans quitter la résidence, en prévention et en suivi léger.”

EN 10 SECONDES — Résidence autonomie : personnes âgées autonomes, pas de soins intégrés, opportunité DOTR sur accès médical de proximité et prévention.

Matrice de Prospection

Identifiez rapidementles établissements prioritaires selon la spécialitémédicale disponible.
Codes :
★★★ Compatibilité forte (P1) ·
★★ Bonne opportunité (P2) ·
★ Opportunité secondaire (P3)

P1 = Prospect prioritaire — qualifier rapidement
P2 = À travailler selon contexte local
P3 = Opportunité secondaire, ne pas forcer

Légende spécialités : MG = Médecine Générale · Coord. = Médecine de Coordination · Psy/Pédopsy = Psychiatrie · MPR = Médecine Physique et Réadaptation · Ortho = Orthophonie

ÉTABLISSEMENT — SPÉCIALITÉS	PRIORITÉ & COMPATIBILITÉ
EHPAD · MG ★★★ · Coord. ★★★ · Psy ★★ · MPR ★★ · Ortho ★★ * P1	SESSAD · MG ★★ · Coord. ★★★ · Pédopsy ★★ · MPR ★★ · Ortho ★★★ * P2
MAS · MG ★★★ · Coord. ★★ · Psy ★★★ · MPR ★★★ · Ortho ★★ * P1	CAMSP · MG ★★ · Coord. ★★ · Pédopsy ★★ · MPR ★ · Ortho ★★★ * P2
FAM/EAM · MG ★★★ · Coord. ★★ · Psy ★★★ · MPR ★★★ · Ortho ★★ * P1	CMPP · MG ★ · Coord. ★★ · Pédopsy ★★★ · MPR★ · Ortho ★★★ * P2
IME · MG ★★ · Coord. ★★ · Pédopsy ★★★ · MPR ★★ · Ortho ★★★ * P1	SAMSAH · MG ★★ · Coord. ★★★ · Psy ★★ · MPR ★★ · Ortho ★★ * P2
IEM · MG ★★ · Coord. ★★ · Psy★★ · MPR ★★★ ·Ortho ★★ * P1	EANM/Foyer · MG ★★ · Coord. ★★ · Psy ★★ · MPR★★ · Ortho★ * P2
EEAP · MG ★★★ · Coord. ★★★ · Psy ★★★ · MPR ★★★ · Ortho ★★ * P1	Rés. Autonomie · MG ★★ · Coord. ★ · Psy ★ · MPR★ · Ortho★ * P2
ITEP/DITEP · MG ★★ · Coord. ★★ · Pédopsy ★★★ · MPR ★ · Ortho ★★ * P1	Domicile/SSIAD · MG ★★ · Coord.★★★ · Psy★★ · MPR★★ · Ortho★★ * P2
	ESAT · MG ★ · Coord. ★ · Psy ★ · MPR ★ · Ortho ★ → P3 R

Si j'ai un médecin

Où prospecter ?

Liceria & Co.
Company

Utilisez ce guide pourorienter votreprospection selonla spécialité médicale disponible.
Chaque colonne identifie les établissements les plus pertinents à cibler en priorité.

Priorité P1 : établissements à fort besoin non couvert.
Priorité P2 : établissements à potentiel identifié.
Priorité P3 : opportunités secondaires à qualifier.

Médecine Générale & Coordination

P1 — EHPAD : médecin référent, suivi résidents, astreinte.
P1 — MAS : généraliste de proximité, suivi polyhandicap.
P1 — FAM / EAM : suivi médical régulier, coordination.
P1 — EEAP : médecin coordonnateur, protocoles soins.
P1 — IME : coordination pédiatrique, bilans.
P1 — EANM / Foyer de vie : suivi médical ponctuel.
P1 — SAMSAH : télécoordination, médecin référent.
P2 — SESSAD : appui médical à distance.
P3 — ESAT : médecine du travail adaptée.
P3 — Résidence autonomie : prévention, téléconsultation.

MPR — Psychiatrie — Orthophonie

MPR:
P1 — MAS, FAM/EAM : rééducation, maintien fonctionnel.
P1 — IEM : spécialité phare, handicap moteur.
P1 — EEAP : MPR polyhandicap, appareillage.
P1 — IME, SESSAD : bilans moteurs, suivi.
Psychiatrie / Pédopsychiatrie :
P1 — ITEP / DITEP : troubles comportementaux.
P1 — IME, CMPP : pédopsychiatrie, suivi.
P2 — CAMSP : dépistage précoce, prévention.
P2 — EHPAD : psychiatrie du sujet âgé.
Orthophonie :
P1 — CAMSP, CMPP : bilans langage, rééducation.
P1 — IME, EEAP : communication, déglutition.
P2 — EHPAD, MAS : troubles déglutition, communication.

Docs On The Road

J'entends ça,
Je pense à ça

Chaquesignal d'alerteentendu lorsd'un entretien est une opportunité commerciale. Associez immédiatement la phrase du prospect à la réponse DOTR adaptée.

Méthode : écoutez activement, notez le signal exact, reformulez avec la solution DOTR correspondante.
Ne proposez jamais une spécialité sans signal identifié.

CE QU'ILS DISENT	CE QUE DOTR APPORTE
« On n'a plus de médecin coordonnateur. » * Médecine de Coordination DOTR	« Nosrésidentsont des troubles du langage non pris en charge. » * Orthophonie DOTR
« Notre médecin traitant ne vient plus. » * Temps médical DOTR — Médecine Générale	« On n'a personne pour les bilans de rééducation. » * MPR — Médecine Physique et Réadaptation
« Les familles se plaignent du suivi médical. » * Médecin référent + compte-rendu structuré	« La coordination entre équipes est difficile. » * Télécoordination + RCP pluriprofessionnelles
« On gère les urgences mais pas le suivi. » * Présentiel programmé + téléconsultation	« On cherche une solution san s embauche fixe. » * Organisation médicale flexible et durable
« On a du mal à trouver un psy pour nos résidents. » * Psychiatrie / Pédopsychiatrie DOTR	« On ne sait pas comment organiser le temps médical. » * DOTR structure et pilote la ressource médicale

LES 10 QUESTIONS DE DÉCOUVERTE

- Quel est le profil exact des personnes accompagnées ?
- Combien de résidents ou usagers accueillez-vous ?
- Quel est votre niveau de médicalisation actuel ?
- Quelles sont vos difficultés d'accès aux soins ?
- Quels professionnels de santé interviennent régulièrement ?
- Avez-vous un médecin coordonnateur ou référent en poste ?
- Quelles spécialités vous manquent le plus aujourd'hui ?
- Avez-vous recours à la télémédecine ou télécoordination ?
- Qui prend les décisions médicales et organisationnelles ?
- Qu'est-ce qui vous empêche d'organiser un suivi médical stable ?

Vocabulaire Commercial

Lechoix des mots conditionne la qualitéde la relation avec vos interlocuteurs médico-sociaux. Adoptez un registre institutionnel, médical et partenarial.

Remplacez systématiquement tout terme commercial générique par un vocabulaire ancré dans les réalités du terrain médico-social et les besoins des équipes.

MOTS À UTILISER ✓

« Temps médical disponible »
« Ressource médicale organisée »
« Médecin référent de l'établissement »
« Parcours de soins coordonné »
« Continuité médicale »
« Réunion pluriprofessionnelle »
« Téléconsultation structurée »
« Accès aux soins des résidents »
« Organisation médicale durable »
« Accompagnement des équipes »

MOTS À ÉVITER ✗

« Vendre une solution »
« Produit », « offre commerciale »
« Client », « prospect »
« Contrat clé en main »
« Logiciel médical »
« Prestataire externe »
« Tarif », « prix », « coût »
« On fait tout à distance »
« Vous n'avez plus besoin de médecin »
« Formule », « pack », « abonnement »

Le Réflexe Commercial

DOTR — Chaîne de Qualification

Structure
→ Résidents

Organisation
→ Ressources

Manque Médical
→ Expertise DOTR

Décideur
→ Opportunité

Appliquer systématiquement cette chaîne à chaque prospect : identifier la structure, qualifier le public accompagné, analyser l'organisation en place et les ressources médicales disponibles.

Chaque maillon révèle le manque médical réel, oriente vers l'expertise DOTR adaptée, identifie le bon décideur et transforme le contact en opportunité commerciale qualifiée.



CARTE MENTALE
Univers & Établissements Cibles

Docs OnThe Road
DOTR Playbook

SENIORS
EHPAD · Résidence Autonomie · Résidence Services Seniors
Expertises : Médecine Générale · Médecine de Coordination · Téléconsultation

DOMICILE & AMBULATOIRE
SAMSAH · SSIAD · Services Autonomie · CMPP · CAMSP
Expertises : Télécoordination · Orthophonie · Pédopsychiatrie

Handicap Adulte Lourd

MAS · FAM / EAM · EANM · Foyer de Vie · ESAT
Priorité P1 : MAS, FAM/EAM
Expertises clés : MPR · Médecine Générale · Psychiatrie · Orthophonie

Handicap Enfant & Ado

IME · IEM · EEAP · ITEP/DITEP · SESSAD
Priorité P1 : EEAP, IEM, IME
Expertises clés : Pédopsychiatrie · MPR · Orthophonie · Coordination

Petite Enfance & Précoce

CAMSP · CMPP · SESSAD
Dépistage précoce, prévention, ambulatoire
Expertises : Orthophonie · Pédopsychiatrie · Coordination des parcours

Notre Métier — En Résumé

Partout où le manque de ressources médicales perturbe l'accès aux soins et le fonctionnement des équipes — DOTR organise une ressource médicale durable.

NOTRE MARCHÉ

Notre marché se trouve partout où le manque de ressources médicales perturbe l'accès aux soins, le parcours des personnes et le fonctionnement des équipes.

APPORTER DU TEMPS MÉDICAL.
ORGANISER LES SOINS.
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES.

